

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : دَالِيَا غَازِي سَعْدُ خَلْفَ اللَّهِ

المحافظة : البحيرة

الحي / المدينة : ايتاي البارود

العنوان : ممم

رقم البطاقة : 28409291802185 رقم التليفون : 01068012681

تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 29-09-1984 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام

----- التعليق على التشخيص :

GR1-E

جورستان افغانستان
روستای پیلانی
لیدی حساب
موسسین رمضان
صحة الحسابات المرفعة
للجنة و مدير

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نفقات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: داليا غازي سعد خلف الله National ID: 28409291802185	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية العراق
 وزارة الداخلية
 جواز سفر
 جازي سعد خلف الله
 جازي
 مركز ابحاث البازوق - البصرة
 ٢٨٤٠٩٧٩١٨٠٢١٨٥
 IM4985943

٢٠٢١/٠٩
 ٢٨٤٠٩٧٩١٨٠٢١٨٥
 ليسانس دراسات اسلامية
 انش
 مشراوي جامعة عبد الهادي عباد الله
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٩/٢١
 ٩

MDT FORM

24 / 1 / 2026 G

Name	داليا محمد	MRN	New: 58
Age	41y.	ID	5346/2021
Menopausal status	Premenopausal	Phone	01068012681
NRS SCORE		Marital status	CNS, 9C91A, CIN
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: DDC

ER:

618

PR:

418

HER 2:

3t.

Ki67:

Sonammammography:

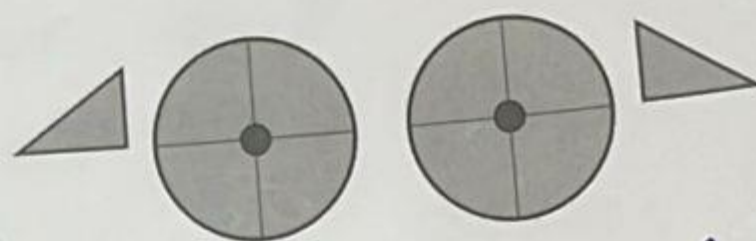
RT but not in 2021

Rec - Neo - TCX6

Mets Workup:

the MRM the Herceptin (1yr)

R



1HPx2

1Tamoxifen (+PORT)
TNM (3yr)

Recommendations:

Shifted to Arimidex 4 months ago
(without MDT) + Zoladex

for Arimidex / Zoladex (to document).
+ Zometa / 6m

MDT OUTCOME & PLAN

In view of having high risk disease. (initially N3)

→ Shift to Bleomycin / Ase h 2 yrs.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: داليا غازي سعد خلف الله		
MR. : 58		
Detailed Medical Report		
		السيد
تجبة طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 38-year-old with triple-positive breast cancer diagnosed in 2022. She underwent right mastectomy and axillary node dissection, followed by radiation therapy to the chest wall and regional nodes. Post-operative systemic therapy consisted of the PHESGO regimen (paclitaxel 80 mg/m² IV on days 1, 8, 15 of a 28-day cycle) combined with ARAMIDEX (anastrozole 1 mg daily), ZOLADEX (goserelin acetate 3.75 mg IM monthly), and ZOMETA (zoledronic acid 4 mg IV monthly). The last documented dose of ZOLADEX was 7-1-2026 and ZOMETA was administered on 7-1-2026. The most recent note indicates that the patient is receiving arimidex and a supplemental treatment with ZOLADEX 10.8 mg (3-4-2026) pending approval. The patient reported lower back pain, prompting an MRI of the lumbosacral spine. No explicit cycle or week count is provided in the notes, so the current status is that the patient is continuing the described endocrine and supportive therapy with ongoing monitoring for pain and potential skeletal complications.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 21-09-2026
	اسماء محمد مصطفى نصر	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / داليا غازي سعد خلف	Request No. : 13006855
Patient No. : 28409291802185	Request Date : 30/05/2022
Path No. : 1477/2022	Verification Date : 15/06/2022
Sex : Female	Financial Category : أورام دار الملحم - نفقة الدولة
Age : 37 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : dr.Enas

Pathology Report

Clinical Data:

Rt breast cancer , post NACT

Nature of the specimen:

Rt MRM specimen, collected at 11:00 am , 29/5/22

Gross Examination:

Rt MRM specimen measured 23x22x4 cm, with covering skin ellipse measured 23x19 cm

- Tumor extent
 - o Number: A fairly defined greyish white rubbery LIQ tumor bed site measured 1x1 cm
 - An UOQ ill defined greyish white area measured 1x0.5 cm
 - o Skin involvement: Free grossly
 - Distance from margins: 2 cm from deep margin
 - Lymph nodes number and size: 12 nodules up to 3x2 cm

Microscopic examination:

Histologic complete response in a previously diagnosed invasive carcinoma

- o Skin involvement: Free nipple & areola
- Lymph node involvement: (0/12)
- Resection Margins: Free deep margin
- o No DCIS
- Histologic response to therapy: Pathologic complete response

Diagnosis:

Rt breast cancer , post NACT , MRM specimen :

- Pathologic complete response in a previously diagnosed invasive carcinoma
- Free nipple & areola
- Free deep margin

Verified by :

dr.esraa magdy



Printing Date : 15/06/2022 12:02:22

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

Patient Name : الأستاذة / داليا غازي سعد خلف	Request No. : 13006855
Patient No. : 28409291802185	Request Date : 30/05/2022
Path No. : 1477/2022	Verification Date : 15/06/2022
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 37 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : dr.Enas

Pathology Report

-Free LNs :(0/12)
-Stage ;ypT0, ypN0

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Menna Nabli

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 15/06/2022 12:02:22

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



Patient Name: Dalia Ghazi Saad Khalaf Allah	Date : 09/11/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 40 Year(s)
Medical ID: 5346/2021	Pat. ID: 12018

Left BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had right MRM

Technique

- Left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- Predominantly fatty of the left breast (ACR A)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No left breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Yasmin Nada

09/11/2024 12:42 PM

PATIENT NAME: DALIA GHAZY SAAD KHALAFALAH GENDER: Female AGE: 37 y	PATIENT ID #: 2021172536 ORDER #: 1359667,1359668 DATE OF SERVICE: 11-Dec-2021 03:51 PM
---	---

Report: - all studies

Multi-slice post contrast CT scan of the chest, abdomen and pelvis revealed:

(I) Chest:

- Retracted right nipple with related fine parenchymal density.
- Prominent right axillary lymph nodes are seen in levels I, II and III, the largest is seen measuring about 1.9 x 1.2 cm in its maximum axial dimensions.
- Bilateral apical reticulations are seen, likely post old granulomatous infection.
- Otherwise, both lung fields show no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density and enhancement. It shows a hypodense non-enhancing para-fissural region at segment IV A, likely a pseudo-lesion.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- The examined axial and appendicular skeleton shows no destructive lytic lesions.

OPINION:

- **Right axillary lymphadenopathy at level I, II and III.**

Patient Name : الأستاذة / داليا غازي سيد خلف	Request No. : 132787
Patient No. : 28409291802185	Request Date : 15/12/2021
Path No. : SR--733/21	Verification Date : 26/12/2021
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 37 Y	Department : Out Patient
Referring Doc. :	IHC No. :
	Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:

Known case of paget's disease of Right nipple, with metastatic axillary lymph nodes.

Nature of the specimen:

Slide revision. Tru-Cut biopsy

Gross Examination:

3 blocks (9037/21 & 9815/21 & 9521/21) & 6 slides

Microscopic examination:

Histological type:

Tru-Cut biopsy of the nipple: Paget's disease of the nipple.

Tru-Cut biopsy of axillary lymph nodes: Showed positive metastatic deposits, compatible with ductal mammary origin.

IHC:

GATA3: Positive nuclear reaction in tumour cells

P63: Highlights the epidermal squamous cells & Negative in the tumour cells.

ER: Strong nuclear reaction in about 50% of tumour cells. Positive, score (6/8)

PR: Moderate nuclear reaction in about 50% of tumour cells. Positive, score (5/8)

Her-2: Strong complete membrane reaction in 10% of tumour cells. Positive, score 3+

Diagnosis:

Right nipple ulcer & axillary lymph node. Tru-cut biopsies:

Tru-Cut biopsy of the right nipple: Paget's disease of the nipple.

Tru-Cut biopsy of axillary lymph nodes: Showed positive metastatic deposits, compatible with ductal mammary origin.

IHC: Please find in Microscopic picture above.

Verified by:

abdelrahman ibrahim

Printing Date : 02/01/2022 13:24:56

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Name : Dalia Ghazi Saad Khalaf Allah
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Gostaf Roseh Hospital

Date : 25-09-2025 10:13
Medical No. : 211042

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History:

- 41-year-old lady, with history of right breast cancer.

Technique:

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings:

- No any abnormal active or cold focal bony lesions that may account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are seen at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine